MÓDULO 11 · IA PARA MEDICAL AFFAIRS

Agentes de IA para flujos de trabajo médicos

Más allá de las herramientas conversacionales de pregunta-respuesta descritas en las lecciones anteriores, la nueva generación de agentes de inteligencia artificial — sistemas capaces de ejecutar secuencias de tareas de forma semiautónoma, combinando búsqueda, análisis y generación de contenido en un flujo continuo— empieza a abrir posibilidades de automatización más profundas para flujos de trabajo repetitivos dentro de Medical Affairs, aunque su adopción exige una disciplina de supervisión humana aún mayor que el uso de una herramienta conversacional puntual.

AGENTES DE IA

- Sistemas que ejecutan secuencias de tareas de forma semiautónoma
- Abren posibilidades de automatización para flujos de trabajo repetitivos
- Exigen una disciplina de supervisión humana aún mayor

Un agente de IA, a diferencia de un simple chatbot, puede encadenar varios pasos de un flujo de trabajo sin intervención humana en cada etapa intermedia: por ejemplo, revisar de forma automática las nuevas publicaciones que aparecen semanalmente en un área terapéutica concreta, filtrar las que son relevantes según criterios predefinidos, extraer los datos clave de cada una, y generar un primer borrador de resumen semanal para el equipo de campo, todo ello sin que un humano tenga que ejecutar manualmente cada uno de esos pasos por separado.

EJEMPLO DE FLUJO ENCADENADO POR UN AGENTE

1. **Revisar**
   Publicaciones nuevas semanales en un área terapéutica
2. **Filtrar**
   Las relevantes según criterios predefinidos
3. **Extraer**
   Los datos clave de cada publicación
4. **Generar**
   Un primer borrador de resumen semanal para el equipo de campo

Aplicaciones emergentes de este tipo de flujos en Medical Affairs incluyen la vigilancia continua de literatura y de escucha médica descrita en el Módulo 10, generando alertas automáticas cuando aparece una publicación o una conversación digital relevante para los gaps de evidencia prioritarios de un producto; la preparación semiautomática de primeros borradores de informes de debrief de congreso a partir de las notas dispersas de todo el equipo, siguiendo la estructura ya trabajada en el Módulo 8; y la organización y priorización de insights capturados por un equipo de MSL, agrupándolos automáticamente por tema y sugiriendo cuáles podrían merecer

atención prioritaria según su frecuencia o su alineamiento con los imperativos estratégicos del Plan Médico.

APLICACIONES EMERGENTES

- Vigilancia continua de literatura y escucha médica con alertas automáticas
- Preparación semiautomática de borradores de debrief de congreso
- Organización y priorización automática de insights del equipo de MSL

El principio de gobernanza que debe regir estos flujos, coherente con la literatura sobre riesgos de la IA generativa en salud, es el de "humano en el bucle" (human-in-the-loop): un agente de IA puede ejecutar los pasos mecánicos y de bajo riesgo de un flujo de trabajo, pero cualquier salida que vaya a comunicarse externamente, que implique una afirmación científica, o que alimente una decisión estratégica relevante, debe pasar por una revisión y aprobación humana explícita antes de su uso, exactamente con el mismo rigor que cualquier otro contenido generado por IA descrito en las lecciones anteriores de este módulo.

PRINCIPIO DE GOBERNANZA: HUMANO EN EL BUCLE

- El agente ejecuta los pasos mecánicos y de bajo riesgo
- Toda salida externa o afirmación científica exige revisión humana explícita
- Con el mismo rigor que cualquier otro contenido generado por IA

Adoptar agentes de IA en el flujo de trabajo de Medical Affairs es todavía, en 2026, un terreno en construcción activa más que una práctica plenamente madura y estandarizada en el sector; los equipos que lo hacen bien son los que empiezan por automatizar tareas de bajo riesgo y alto volumen repetitivo, mantienen supervisión humana rigurosa en cada salida relevante, y documentan con trazabilidad completa qué pasos ejecutó el agente y qué revisión humana se aplicó antes de cualquier uso externo.

- En 2026, todavía un terreno en construcción activa, no una práctica madura
- Los equipos que lo hacen bien empiezan por tareas de bajo riesgo y alto volumen
- Documentan con trazabilidad completa los pasos del agente y la revisión humana